Revisão de Literatura – Faceta direta em resina composta

Oct 25, 2026 · @Thamyres Tosarelli

Antes de usar

Este é um rascunho da Revisão de Literatura com os 30 artigos, escrito a partir dos resumos, métodos e conclusões de cada um. Ele segue o modelo do TCC de exemplo: um parágrafo por artigo, em ordem de ano dentro de cada tópico.

- **Confira cada parágrafo no PDF** antes de copiar para o TCC. Você responde por cada frase na banca.
- **Reescreva com as suas palavras.** Muitas faculdades tratam texto feito por IA como plágio; confira a regra da sua e com a professora.
- **Faça o Guia de estudo no fim deste documento.** É ele que garante que você domina o conteúdo.
- Trechos marcados com **[conferir]** dependem de um detalhe que precisa ser checado no artigo.

4 REVISÃO DA LITERATURA

4.1 Facetas diretas: conceito, indicações e vantagens

Lima et al. (2020) realizaram uma revisão integrativa sobre o fechamento de diastemas por meio de facetas em resina composta associadas ao clareamento dental. Segundo os autores, a técnica direta apresenta menor tempo de execução, baixo custo e resultado imediato, além de dispensar o desgaste da estrutura dental. Destacaram que o planejamento deve considerar aspectos periodontais e ortodônticos e que retornos periódicos favorecem resultados estéticos e funcionais em longo prazo.

Silva, I. et al. (2021) realizaram uma revisão de literatura sobre os aspectos gerais das facetas diretas em resina composta em dentes anteriores, comparando-as a outros tratamentos, como clareamento, ortodontia e laminados cerâmicos. Os autores apontaram que as queixas mais comuns dos pacientes envolvem cor, contorno e presença de diastemas. Concluíram que as facetas diretas permitem mimetizar o dente com naturalidade, com baixo custo, possibilidade de sessão única, mínimo ou nenhum desgaste e facilidade de reparo, sendo fundamental a colaboração do paciente para a longevidade do material.

Alves, Peres e Lima (2022) realizaram uma revisão de literatura com o objetivo de discorrer sobre as indicações e técnicas de aplicação das resinas compostas diretas. Os autores descreveram que as facetas podem ser confeccionadas pela técnica direta, com resina composta, ou indireta, com porcelanas e cerâmicas. Entre as vantagens da técnica direta, citaram a maior preservação da estrutura dentária remanescente, o potencial de reparo e a reprodução adequada de morfologia, cor, translucidez e opacidade. Ressaltaram, porém, que sua resistência mecânica pode ser inferior à das restaurações indiretas.

Brito, Ferreira e Yamashita (2022) realizaram uma revisão narrativa sobre as indicações e a longevidade das facetas de resina composta diretas e indiretas, incluindo trabalhos publicados entre 2001 e 2022 no Google Acadêmico, na SciELO e no Periódicos CAPES. Segundo os autores, as facetas diretas são indicadas para corrigir alterações de cor, forma e posição, dentes escurecidos ou manchados, amelogênese imperfeita, microdontias e perdas estruturais por desgaste. Concluíram que o planejamento correto e os fatores de execução, acabamento e polimento são primordiais para a previsibilidade e a durabilidade das facetas.

Soares e Borges (2023) realizaram uma revisão integrativa nas bases PubMed, SciELO e Google Acadêmico com o objetivo de apresentar as técnicas, as indicações, os materiais, as vantagens, as desvantagens e a manutenção das facetas em resina composta direta. Os autores descreveram a faceta direta como o recobrimento da face vestibular, um procedimento menos invasivo por não exigir preparo prévio, exceto quando há necessidade de ajustes de anatomia. Destacaram ainda que a técnica pode ser concluída em sessão única, com ótimo custo-benefício, cabendo ao cirurgião-dentista dominar a técnica e indicá-la de forma individualizada.

Dominguez et al. (2024) realizaram uma revisão abrangente sobre as propriedades dos materiais, as técnicas de aplicação e os avanços tecnológicos associados às facetas de resina composta. Os autores abordaram o planejamento estético, incluindo análise facial, seleção de cor e mock-up diagnóstico, além das vantagens, limitações, longevidade e questões éticas e legais do tratamento. Concluíram que as facetas em resina composta continuam sendo uma solução eficaz e confiável para melhorar a estética do sorriso.

Lanzaretti et al. (2025) realizaram uma revisão narrativa nas bases PubMed, Scopus e ScienceDirect sobre a aplicação clínica, a evolução dos materiais e a satisfação dos pacientes com facetas diretas, além de explicarem a técnica passo a passo. Segundo os autores, as facetas diretas são um substituto prático, acessível e reversível aos laminados cerâmicos, com resultado imediato e pouco preparo dental. Apontaram como limitações a suscetibilidade ao manchamento, a menor durabilidade e a necessidade de manutenção, e destacaram que as resinas nano-híbridas e nanoparticuladas melhoraram o polimento, a durabilidade e a estabilidade de cor.

4.2 Resinas compostas: propriedades e estabilidade

Irgang et al. (2020) realizaram uma avaliação clínica retrospectiva de facetas diretas confeccionadas com resinas microparticuladas ou universais (micro-híbridas e nano-híbridas), utilizando os critérios FDI e USPHS. Foram examinados 28 pacientes, com média de idade de 42,9 anos, e 74 facetas, com tempo médio de três anos em boca, variando de seis meses a dez anos. As facetas apresentaram taxa de sobrevivência de 77%, com 17 falhas, das quais três foram perdas totais, todas no grupo das resinas universais. As resinas microparticuladas tiveram melhor desempenho quanto ao brilho superficial, manchamento, correspondência de cor e adaptação marginal, e os dois critérios de avaliação mostraram resultados semelhantes.

Fernandes et al. (2022) avaliaram, in vitro, a microdureza de duas resinas compostas nanoparticuladas submetidas a diferentes técnicas de fotopolimerização. Quarenta corpos de prova foram divididos em quatro grupos (n=10): Filtek Z350 XT e Filtek One Bulk Fill, cada uma polimerizada pela técnica imediata ou pela técnica de pulso tardio. A resina Filtek Z350 XT apresentou maior dureza que a Filtek One Bulk Fill em ambas as técnicas, e a técnica imediata resultou em valores de dureza significativamente maiores. Os autores concluíram que a técnica convencional atinge maior dureza que a técnica de polimerização alternativa.

Tozo-Burgos, Escalante-Otárola e Sánchez-Tito (2025) avaliaram, in vitro, o efeito de uma bebida energética sobre a microdureza e a rugosidade superficial de cinco resinas compostas de alta translucidez: Filtek Z350 XT Translucent, Forma Trans, Palfique LX5, Beautifil II e Opallis T-Neutral. As amostras foram imersas em Red Bull por dez minutos ao dia durante 30 dias e mantidas em saliva artificial entre as imersões. Todas as resinas apresentaram redução progressiva da microdureza e aumento da rugosidade. A Filtek Z350 XT manteve a maior dureza, a Forma Trans foi a mais estável e a Beautifil II foi a mais afetada, levando os autores a concluir que materiais com nanoaglomerados e zircônia resistem melhor à degradação ácida.

4.3 Planejamento: enceramento, mock-up, guias e clareamento

Reis et al. (2018) relataram um caso clínico com o objetivo de mostrar a importância do planejamento reverso na reabilitação estética com facetas diretas. A paciente, do gênero feminino e com 21 anos, apresentava alteração de cor, forma e alinhamento dos dentes. Após enceramento diagnóstico, foi confeccionado um mock-up com resina bisacrílica (Protemp), ajustado conforme as queixas da paciente, seguido de clareamento de consultório e facetas diretas, com resina IPS Empress Direct para a dentina e Filtek Z350 para o esmalte. Os autores concluíram que o mock-up motivou a paciente e deu maior previsibilidade ao resultado e segurança à execução, tanto para o cirurgião-dentista quanto para a paciente.

Pereira et al. (2020) relataram um caso de reabilitação de dentes anteriores com facetas em resina composta em um paciente do sexo masculino, de 23 anos, insatisfeito com a estética do sorriso. O exame clínico mostrou restaurações insatisfatórias nas incisais e proximais dos incisivos centrais superiores e desarmonia dos dentes 12, 22 e 23 com a face. O tratamento incluiu enceramento diagnóstico em articulador semiajustável, três sessões semanais de clareamento com peróxido de hidrogênio a 35% e espera de 21 dias para estabilização da cor. Em seguida, foram removidas as resinas antigas e as facetas foram confeccionadas com guia de silicone, incrementos de resina de dentina e esmalte, acabamento com pontas diamantadas e polimento com borrachas, discos e pasta diamantada. Os autores concluíram que as facetas em resina composta são um tratamento viável para se alcançar um sorriso harmônico.

Oliveira et al. (2021) relataram o fechamento de diastemas pela técnica direta em resina composta, guiado por enceramento diagnóstico, em uma paciente de 21 anos com diastemas entre os incisivos centrais e laterais superiores. A cor foi selecionada pela técnica de incrementos de resina sobre o dente, e o procedimento foi realizado sob isolamento absoluto modificado. A parede palatina foi confeccionada com o auxílio de guia de silicone obtida do enceramento, e o acabamento e polimento foram realizados após sete dias. Os autores concluíram que a técnica direta é uma excelente alternativa para o fechamento de diastemas, desde que se considerem a habilidade do operador e a colaboração do paciente, e que o enceramento e a guia palatina foram primordiais para a previsibilidade do tratamento.

Rocha et al. (2021) descreveram um caso de intervenção restauradora nos dentes anteriores superiores de um paciente que não gostava dos dentes amarelados, pequenos, separados e levemente desalinhados. O exame clínico mostrou diastemas, incisivos laterais conoides e caninos levemente girovertidos para distal. O tratamento consistiu em clareamento de consultório, enceramento diagnóstico para planejar o caso e confeccionar a guia palatina, e facetas em resina composta com resinas de efeito para mimetizar as características naturais. Os autores destacaram que o clareamento reduziu a necessidade de desgaste e concluíram que o sucesso depende do conhecimento do cirurgião-dentista, do planejamento minucioso e dos cuidados do paciente, que foi orientado a retornar semestralmente para manutenção.

4.4 Facetas diretas em situações clínicas específicas

Korkut, Yanıkoğlu e Günday (2013) descreveram a técnica de facetas laminadas diretas em resina composta em três pacientes com problemas estéticos relacionados a fraturas, escurecimentos e uma restauração antiga deficiente. No primeiro caso, um paciente do sexo masculino, de 37 anos, apresentava fratura das bordas incisais. Os autores apontaram como vantagens da técnica direta a ausência de etapa laboratorial, o menor custo, a reversibilidade, a facilidade de polimento e de reparo intraoral e a boa adaptação

marginal, e como desvantagens a menor resistência ao desgaste, o manchamento e as fraturas. Após seis meses de acompanhamento, concluíram que as facetas diretas podem ser uma opção de tratamento para problemas estéticos semelhantes em dentes anteriores.

Bastos et al. (2018) avaliaram o desempenho clínico de facetas diretas confeccionadas com resina composta de carga supra-nano esférica em uma paciente de 39 anos. Os incisivos e caninos superiores apresentavam alteração de cor causada pelo uso de medicamentos, além de sinais de bruxismo. O plano de tratamento incluiu duas sessões de clareamento de consultório com peróxido de hidrogênio a 35%, remoção das restaurações inadequadas e confecção das facetas na cor A1 para dentina e esmalte. Após seis meses, as restaurações apresentavam bom aspecto clínico, sem acúmulo de biofilme nem desgaste abrasivo, sugerindo desempenho promissor desses novos compósitos.

Dias et al. (2020) relataram a reabilitação estética de uma paciente de 21 anos com manchas brancas lisas, brilhantes e bem delimitadas na região cervical dos dentes anteriores superiores, diagnosticadas como lesões de cárie inativa. O tratamento associou clareamento dental de consultório a facetas diretas em resina composta, com enceramento diagnóstico, preparo mínimo com pontas diamantadas de polimento, incrementos de resina de dentina e esmalte (Filtek Z350 XT) e polimento com discos, taças e feltros. Os autores concluíram que o diagnóstico correto e o planejamento adequado permitiram um resultado satisfatório, que atendeu às exigências estéticas da paciente.

Falcão et al. (2023) relataram um caso de faceta direta em resina composta com pigmentos opacificadores em um paciente do sexo masculino, de 54 anos, com alteração de cor severa do dente 21. O dente tinha histórico de trauma, tratamento endodôntico e contraindicação para novo clareamento interno. Foi utilizada uma mistura fluida de três opacificadores, cujo valor foi verificado por fotografias em preto e branco, seguida de estratificação com resina translúcida na palatina, resina de dentina opaca e resina acromática translúcida para o esmalte. Na reavaliação após 30 dias e sete meses, a cor permanecia estável, e os autores concluíram que a técnica traz resultados satisfatórios em sessão única e com alta previsibilidade.

Joshi (2025) relatou a reabilitação estética de uma paciente de 43 anos com múltiplas lesões de cárie, dente 22 escurecido e sem vitalidade, exposição gengival excessiva e assimetria dos dentes e da gengiva. O plano incluiu enceramento diagnóstico, tratamento endodôntico e clareamento interno do dente 22, aumento de coroa clínica para corrigir a simetria gengival, tratamento das cáries e, por fim, facetas diretas em resina composta. Concluiu-se que a abordagem conservadora preserva a estrutura dental, reduz o risco de falhas futuras e proporciona resultado estético excelente.

Vookanti et al. (2026) relataram o tratamento estético de dentes com fluorose moderada por meio de facetas diretas em resina composta, realizado em sessão única. A cor foi selecionada pela técnica do botão de resina, o preparo foi mínimo e restrito às áreas manchadas (cerca de 0,5 a 0,75 mm no terço médio), e a restauração foi feita com resina nano-híbrida em camadas policromáticas, seguida de acabamento e polimento com discos. Os autores concluíram que, com seleção adequada do caso e execução cuidadosa, as facetas diretas são uma solução previsível, conservadora e de baixo custo para a fluorose. **[conferir: sobrenome do primeiro autor no PDF]**

4.5 Facetas diretas e o periodonto

Silva, B. et al. (2021) relataram um caso de restabelecimento da estética do sorriso por meio de cirurgia periodontal associada a facetas em resina composta. A paciente apresentava grande exposição gengival ao sorrir e restaurações em resina deficientes. Após planejamento digital para definir as medidas ideais dos dentes, foi realizada gengivoplastia e, noventa dias depois, clareamento dental e facetas em resina composta do dente 15 ao 25. Os autores concluíram que a abordagem multidisciplinar entre periodontia e dentística é essencial para um resultado ideal e duradouro, com impacto positivo na autoestima e na qualidade de vida da paciente.

Santos et al. (2022) realizaram uma revisão bibliográfica integrativa sobre o impacto das facetas diretas em resina composta no tecido periodontal, com base em cinco livros e 17 artigos publicados entre 2003 e 2021 na SciELO, no Google Acadêmico e no PubMed. Segundo os autores, as facetas em resina são uma alternativa conservadora, de resultado imediato e baixo custo, mas o uso indiscriminado da técnica pode causar injúrias periodontais. Concluíram que princípios como o espaço biológico devem ser respeitados, mantendo-se uma margem gengival mínima de 3 mm, para evitar inflamação gengival e sequelas periodontais.

Lima, Amorim e Pereira (2023) relataram a reabilitação estética de uma paciente com sorriso gengival e dentes curtos por meio de gengivectomia em bisel interno associada a facetas em resina composta. Os autores explicaram que a gengivectomia remove o excesso gengival e aumenta a coroa clínica, enquanto as facetas devolvem forma, cor, opacidade e translucidez aos dentes anteriores. Concluíram que a abordagem conjunta, com respeito aos princípios estéticos e bom planejamento, estabeleceu melhor forma, contorno e tamanho tanto da gengiva quanto dos dentes, exigindo habilidade e experiência do cirurgião-dentista.

4.6 Falhas, substituição e satisfação do paciente

Bento et al. (2021) relataram o impacto psicossocial de uma reabilitação estética anterior com resina composta direta em um paciente do sexo masculino, de 32 anos, que se queixava de “espaço” entre os dentes e “cor amarelada”. O exame clínico mostrou

diastema entre os dentes 11 e 21 por desproporção de tamanho. O tratamento associou clareamento de consultório e caseiro a facetas diretas nos dentes 13 a 23, com fotografias, enceramento diagnóstico, mock-up e guia de silicone para a face palatina. O questionário OHIP-14, aplicado antes e depois do tratamento, passou de 24 para 5 pontos, e os autores concluíram que o tratamento promoveu melhor qualidade de vida.

Cruz et al. (2021) descreveram a substituição de facetas em resina composta insatisfatórias nos dentes anteriores superiores, em busca de adequação estética e anatômica. O paciente se queixava da coloração das facetas antigas e de sangramento durante a higiene oral. Foram realizados clareamento imediato da arcada inferior, remoção das dez facetas preexistentes e confecção de dez novas facetas seguindo princípios estéticos e funcionais. Os autores concluíram que, para evitar frustrações e retratamentos, são necessários indicação correta, bom planejamento, domínio da técnica, conhecimento da anatomia dental, respeito aos tecidos periodontais e ética profissional.

Cruz et al. (2023) realizaram uma revisão de literatura nas bases PubMed, Lilacs e Google Acadêmico sobre as principais falhas na execução de facetas em resina composta em dentes anteriores. Os autores apontaram como falhas a anatomia dental incorreta, a oclusão inadequada, o manejo inadequado do material, os problemas periodontais e a infiltração cariosa por má adaptação. Concluíram que a principal causa das falhas é o desempenho do cirurgião-dentista, a quem cabe escolher a resina e a técnica incremental adequadas, além de considerar fatores do paciente, como forças oclusais, mudanças de pH, má higiene e hábitos parafuncionais, que podem levar ao descolamento ou à fratura das facetas.

4.7 Longevidade: facetas diretas x indiretas

Nalbandian e Millar (2009) realizaram um estudo clínico retrospectivo para comparar a opinião dos pacientes sobre a melhora estética obtida com facetas diretas em resina composta e com facetas indiretas de porcelana. Foram consultados 145 pacientes, dos quais 96 responderam, cada um tratado com dez facetas de resina (Vitalescence) ou dez de porcelana (Fortress), avaliando cor, forma, tamanho, linha do sorriso e aparência facial antes e depois do tratamento por meio de escalas visuais analógicas. Não houve diferença estatística na melhora estética entre os dois materiais, e a conservação do dente, o tempo de tratamento e os custos de reparo e substituição favoreceram as facetas de resina. Os autores concluíram que a escolha do material não afeta significativamente a percepção estética do paciente e que, quando informados, os pacientes podem preferir a opção mais conservadora.

Teixeira et al. (2022) realizaram uma revisão narrativa no PubMed com o objetivo de comparar a longevidade de facetas diretas e indiretas em dentes anteriores, incluindo apenas estudos clínicos e excluindo restaurações posteriores, estudos laboratoriais e revisões. Segundo os autores, as facetas diretas de resina composta apresentaram maior

instabilidade de cor, mas maior facilidade no manejo da forma e da cor, enquanto as facetas indiretas de porcelana ofereceram maior resistência e estabilidade de cor. Concluíram que as facetas indiretas em dentes anteriores mostraram sobrevida relativamente maior que as restaurações diretas.

Vaz, Lopes e Toledo Neta (2022) relataram um caso de reabilitação estética como alternativa ao tratamento ortodôntico em uma paciente de 21 anos com desalinhamento dos dentes anteriores. A paciente optou por facetas de cerâmica reforçada por dissilicato de lítio nos seis dentes anteriores e por resina composta Z350 XT nos pré-molares. Os autores concluíram que a associação de diferentes materiais restauradores corrigiu o alinhamento insatisfatório e devolveu estética e função, destacando a importância do planejamento com fotografias digitais, desenho do sorriso e comunicação entre dentista e paciente.

Galvão et al. (2025) realizaram uma revisão sistemática, registrada no Prospero, para identificar se existe diferença nas taxas de sobrevivência entre facetas de resina composta diretas e indiretas em dentes anteriores. A busca nas bases PubMed, Embase e Cochrane, sem restrição de ano ou idioma, encontrou 50 artigos, dos quais cinco estudos clínicos foram incluídos. A maioria dos estudos demonstrou maior taxa de sobrevida para as facetas diretas, e os motivos mais comuns de falha, em ambas as técnicas, foram o descolamento e a fratura. Devido à alta heterogeneidade dos estudos, não foi possível realizar análise quantitativa, e os autores concluíram que as facetas diretas em dentes anteriores parecem apresentar maior longevidade que as indiretas.

Guia de estudo

Em 5 dias de 1 hora, você passa por todos os 30 artigos e termina capaz de explicar e defender a revisão sem olhar o texto. O método junta três coisas que fixam conteúdo: conferir na fonte, reescrever com as próprias palavras e se testar sem consultar.

A história da revisão em 7 frases

Decore esta sequência. Ela é o fio que liga os 30 artigos e serve de resposta curta para quase toda pergunta da banca.

1. **4.1** A faceta direta é conservadora, barata, feita em sessão única e fácil de reparar, mas mancha mais e resiste menos que a indireta.
2. **4.2** O resultado depende da resina e da polimerização: microparticuladas mantêm melhor brilho e cor, e bebidas ácidas desgastam todas.
3. **4.3** O sucesso começa no planejamento: clareamento antes, enceramento, mock-up e guia de silicone.
4. **4.4** A técnica resolve casos difíceis: dente escurecido, fluorose, cárie inativa e fratura.

5. **4.5** A gengiva precisa ser respeitada e, às vezes, corrigida antes, com gengivectomia ou gengivoplastia.
6. **4.6** A maioria das falhas vem do profissional e dos hábitos do paciente, e um bom resultado melhora a qualidade de vida.
7. **4.7** Sobre durar mais, a literatura diverge: diretas vencem as indiretas de resina, mas perdem para a porcelana.

O método de cada dia (1 hora)

1. **Leia os parágrafos do tópico do dia** neste documento (10 min).
2. **Abra cada PDF** e confira resumo, método e conclusão contra o parágrafo. Corrija o que estiver diferente (20 min).
3. **Reescreva cada parágrafo no seu documento do TCC sem olhar este texto**, só com o PDF aberto. É esse passo que faz o conteúdo virar seu (20 min).
4. **Teste-se:** cubra a coluna de respostas da tabela abaixo e responda em voz alta as perguntas do dia (5 min).
5. **Explique o tópico em 2 minutos**, em voz alta, como se fosse para um colega do primeiro período (5 min).

Plano dos 5 dias

Dia	Tópicos	Artigos
1	4.1	7
2	4.2 e 4.3	7
3	4.4	6
4	4.5 e 4.6	6
5	4.7 + revisão das perguntas da banca	4

- [ ] Dia 1 concluído
- [ ] Dia 2 concluído
- [ ] Dia 3 concluído
- [ ] Dia 4 concluído
- [ ] Dia 5 concluído

Perguntas de autoteste

Cubra a coluna da direita e responda antes de olhar.

Pergunta	Resposta
Quais as 4 vantagens da faceta direta citadas por quase todos os autores?	Conservadora, baixo custo, sessão única e fácil reparo
E as desvantagens?	Manchamento, menor resistência ao desgaste e à fratura, necessidade de manutenção
Qual resina teve melhor brilho e cor em Irgang et al. (2020)?	A microparticulada
Qual a taxa de sobrevivência em Irgang et al. (2020)?	77%, em 74 facetas de 28 pacientes
Qual técnica de fotopolimerização deu mais dureza em Fernandes et al. (2022)?	A imediata (convencional)
O que a bebida energética fez com as resinas em Tozo-Burgos et al. (2025)?	Reduziu a dureza e aumentou a rugosidade de todas
Para que serve o mock-up, segundo Reis et al. (2018)?	Mostrar o resultado antes, motivar o paciente e dar previsibilidade
Por que esperar 21 dias depois do clareamento (Pereira et al., 2020)?	Para a cor estabilizar antes de escolher a cor da resina
Para que serve a guia de silicone ou palatina?	Construir a parede palatina na forma planejada no enceramento
Como Falcão et al. (2023) mascararam o dente escurecido?	Com mistura de três pigmentos opacificadores antes da estratificação
Que diagnóstico tinham as manchas brancas em Dias et al. (2020)?	Cárie inativa
Que margem gengival Santos et al. (2022) recomendam respeitar?	Mínimo de 3 mm, para preservar o espaço biológico
Quando associar cirurgia periodontal às facetas?	Em sorriso gengival ou dentes curtos (Silva, B. et al., 2021; Lima, Amorim e Pereira, 2023)
Qual a principal causa de falhas, segundo Cruz et al. (2023)?	O desempenho do cirurgião-dentista
Como Bento et al. (2021) mediram a qualidade de vida?	Questionário OHIP-14: caiu de 24 para 5 pontos (menor = melhor)

Pergunta	Resposta
Os pacientes de Nalbandian e Millar (2009) viram diferença estética entre resina e porcelana?	Não; e a resina venceu em conservação, tempo e custo de reparo
O que Galvão et al. (2025) concluíram?	Diretas parecem durar mais que indiretas de resina; falhas: descolamento e fratura
Por que Teixeira et al. (2022) chegaram ao resultado oposto?	Compararam a resina com a porcelana, que é mais resistente

Perguntas prováveis da banca

- **“Por que escolher faceta direta e não laminado cerâmico?”** Porque preserva estrutura, custa menos, é feita em uma sessão e pode ser reparada; e os pacientes não perceberam diferença estética (Nalbandian e Millar, 2009).
- **“Qual dura mais?”** Depende da comparação: contra a indireta de resina, a direta parece durar mais (Galvão et al., 2025); contra a porcelana, a porcelana dura mais (Teixeira et al., 2022).
- **“Quando você não indicaria?”** Em pacientes com hábitos parafuncionais, forças oclusais altas ou má higiene, que levam a descolamento e fratura (Cruz et al., 2023).
- **“Qual a maior limitação da literatura que você revisou?”** A maioria é relato de caso e revisão narrativa, com poucos estudos clínicos de acompanhamento longo; até a revisão sistemática encontrou só cinco estudos.
- **“Por que clarear antes?”** Para escolher a cor da resina sobre a cor final e reduzir o desgaste necessário (Rocha et al., 2021).